

速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨、說明一及二

簽 於 醫審及藥材組

115年4月28日

主旨：有關部長同意接見UCB優時比台灣等人拜會一案，擬具談參資料1份（附件1），請核示。

說明：

- 一、依據衛生福利部食品藥物管理署(下稱食藥署)115年4月7日電子郵件辦理（附件2）。
- 二、優時比公司（UCB）預計於115年5月25日（星期一）下午3時整至下午4時假衛生福利部10樓西側貴賓室拜會部長（附件3）。
- 三、優時比公司（UCB）提供簡報資料如附件4，經檢視，涉本署權責範圍議題如下，本署預擬談參資料(同附件1)：

（一）加速創新療法引進台灣：新產品與新適應症的審查合作

會辦單位：
第一層決行 01-02
承辦單位

會辦單位

核稿

決行

技士洪平 0428 1150

視察曾尹 0428 1150

簡任杜安瑋 0428 1150

副組長張如蕙 1150428 2037

參議戴雪詠 0428 1150

醫審及藥材組 1150428 0873

副組長張作貞 11504301000

主任秘書劉林義 0430 1140

創署長顏家瑞 0430 1201

衛生福利部 中央健康保險署 藥亮

複閱	醫審及藥材組 1150428 黃育文	參議戴雪詠
	參議張惠萍	副組長張如蕙 1150506 11507
	簡任杜安瑋	

監印	校對	複閱	發文	歸檔頁數	
				42	 醫審及藥材組 1150671144

主旨摘要：有關部長同意接見UCB優時比台灣等人拜會一案，擬具談參資料1份（附件1），請核示。

（二）強化必要藥品之供藥韌性

擬辦：

- 一、將旨揭資料以電子郵件提供予食藥署，俾利後續談參資料彙整。
- 二、請鈞長指派出席名單(各單位限1位)。

台灣優時比公司拜會部長

談參資料

壹、會議時間：115 年 5 月 25 日(星期一)下午 3 時至 4 時

貳、會議地點：衛生福利部 10 樓貴賓室

參、會議出席人員：

一、台灣優時比公司

單位職稱	姓名
UCB 國際市場總裁	Ms. Athanasia Gkiouleka
UCB 東國際市場副總裁	李宜真
UCB 台灣總經理	郭佳薇
UCB 台灣罕病暨癲癇藥物處長	孫崇原
UCB 台灣市場准入、永續發展暨 對外事務處長	羅柏青
UCB 台灣法規處長	許書諭
UCB 台灣神經醫學事業處主管	郭睿臻
UCB 東國際市場副總裁行政特助	劉旅帆

二、衛生福利部(陪同出席人員)

單位職稱	職稱	姓名
衛生福利部	部長	石崇良
衛生福利部	常務次長	莊仁祥
科技發展組	技監兼任執行長	劉明勳
醫藥品查驗中心		
資訊處	處長	李建璋
食品藥物管理署	署長	姜至剛
中央健康保險署	參議	戴雪詠

肆、談參資料(依據台灣優時比公司建議談話內容重點彙整)：

- 一、Topic 1 : Accelerating Access to Innovative Therapies in Taiwan and the NHI System 加速創新療法引進台灣：新產品與新適應症的審查合作：

Key Questions 1 :

How would you describe the recent progress in Taiwan's new drug regulatory and reimbursement review timelines, and what future directions MOHW envisions for accelerating access? 如何評價近期台灣新藥法規及健保給付審查時程的進展情況？未來衛福部在加速患者取得新藥方面，有何方向規劃？

【健保署】

- (一) 為加速健保新藥納入給付，健保近年推動多項創新藥品審查策略：

1. 法規面

於 2025 年 4 月 26 日公告修正「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」部分條文，兼顧藥品供應穩定性、用藥可及性與產業升級，包含建立誘因支持新藥在地製造、藥價合理保障及適時調整健保支付價格等，並鼓勵學名藥與生物相似藥及早進入市場。各項優惠已於政策面實質運用。

2. 制度面

- (1) 2023 年實施暫時性支付制度；2024 年推動平行送審機制，將新藥核價審查時間縮短至最快可於取得藥證後 6 個月納入健保給付。

- (2) 2024 年成立健康政策與醫療科技評估中心(CHPTA)專責辦公室，強化醫療科技評估，以實證為基礎之支付，並將設置行政法人國家醫療科技評估中心。

3. 預算面

- (1) 2025 年健保藥品相關預算共約 101.27 億元，2026 年達 104.38 億元(包含總額內新醫療科技 25.59 億元、藥品給付規定範圍改變 24.29 億元及非癌藥之暫時性支付專款 4.5 億元；加上總額外公務預算挹注 50 億元至癌症新藥暫時性支付專款)，大幅增加新藥收載項目。
- (2) 擴大新藥預算來源，2025 年設立「癌症新藥暫時性支付專款」，2025 及 2026 年各編列 50 億元。2025 年透過癌症新藥暫時性支付專款，增加收載 10 項癌症新藥/擴增給付規定(涵蓋 8 種癌別)，加速接軌國際治療指引，提升病人新藥之可近性。

(二) 健保給付審查時程的進展情況：

1. 自 2024 年起，透過 CHPTA 專責辦公室的輔助，2024 年及 2025 年廠商送件到提第一次專家會議的平均天數為 3.7~3.9 個月，相較 112 年 4.3 個月，有顯著提升。
2. 自 2024 年平行送審機制推行後，截至 2026 年 5 月，共 8 項新藥採平行送審公告生效給付，自取得藥證至生效之中位數約 9.5 個月(最短為約 3.5 個月)。
3. 癌症新藥暫時性支付：2025 年透過癌症新藥暫時性支付專款共收載 10 項藥品，其中 8 項為食藥署查驗登記加速核准案件，且其中 6 項藥品三大 HTA 組織並未皆建議，健保給付先於十國。

(三) 健保署將持續精進新藥納入健保收載流程，並期透過成立行政法人國家醫療科技評估中心，強化我國醫療科技評估人才及量能，提升國人用藥可近性。

【食藥署】

(一) 保障國際藥廠持續引進新藥：

1. 食藥署為增進新藥可近性，持續透過國際法規協和化、

建立各類新藥加速審查機制，並藉國際合作推行信賴審查，鼓勵新藥在台上市：

- (1) 國際法規協和化：持續參與國際法規協和會(ICH)及國際藥政主管機關聯盟(ICMRA)，建立與國際一致的審查標準與管理規範。
 - (2) 各類新藥加速審查機制：目前食藥署已針對小兒或少數嚴重疾病，以及可滿足國內醫療迫切需求的新藥，制定新藥查驗登記加速核准機制與優先審查機制。申請者經過事前認定後，申請查驗登記時即可適用該等機制，採用替代療效指標或縮短審查時間做法，有利新藥在台及早上市。
 - (3) 信賴審查(Review Reliance)合作：食藥署刻正逐步採取信賴審查措施，參考醫藥先進國家之審查報告，以減少重複審查並加速藥品核准。其中，新藥查驗登記精簡審查機制：藉由參考美歐日審查報告大幅縮短審查天數；台日新藥審查合作，係藉由參考核准方審查報告，有助建立台日雙邊審查互信，並有助新藥在雙邊取得核准上市。
 - (4) 上市後變更信賴審查：以個案申請方式，由申請者提出規劃，並向各參與國家同步送審。各國法規單位審查時以 EMA 審查報告為依據，在加密平台分享審查議題並由申請者一次性回復，提升審查效率並有助了解國際間審查考量一致性，同時也縮短各國核准時程。
2. 食藥署定期與各製藥公、協會進行溝通，聽取業界建議並優化新藥審查措施。優時比公司若有對新藥審查機制或相關審查指引之具體建議，也歡迎與食藥署溝通說明。

Key Questions 2 :

Building on existing parallel review and temporary reimbursement

mechanisms, would the government consider an accelerated pathway for rare diseases? 在現有的「平行審查」與「暫時性支付」機制基礎上，政府是否會考慮針對罕見疾病設立加速審查通道？

【健保署】

罕藥於 103 年起，經公告為「適用罕見疾病及藥物防治法之藥物」，且取得衛生福利部食品藥物管理署核准之專案進口或專案製造函，廠商未取得藥品許可證，即可向健保署建議收載，且在尚未取得藥品許可證之情形下亦可提至藥物共同擬訂會議討論收載。爰現行健保罕藥的審查已優於平行送審機制，且已列為優先審查案件，以提升病人用藥可近性。

Key Questions 3 :

Would the government consider exploring more value based healthcare models, such as outcome based MEAs, to improve access to innovation while maintaining budget stability? 政府是否願意探索更多「價值導向醫療模式」，例如以療效結果為基礎的 MEA 模式，以在維持預算穩定的同時改善創新藥物的可及性？

【健保署】

- (一) 為因應新藥引進過程中因臨床證據、成本效益或財務風險等不確定性所帶來的挑戰，健保署透過藥品給付協議與風險分擔機制等，提供廠商多元方式納入健保，在健保總額制度下，使新藥納入健保收載可更靈活、彈性的運用，以達促進創新藥給付與上市速度之目標，讓病人可儘快使用到藥物及降低其經濟負擔。
- (二) 目前健保除以財務為基礎的給付協議外，亦有簽訂以療效為

基礎的協議(如 Zolgensma)。針對以療效為基礎的給付協議，健保持開放態度，尤其是罕病或是基因療法等新治療藥物，將依據藥物的特性、療效證據及病人需求，與廠商共同協商，靈活調整最適宜的給付模式，以兼顧病人醫療品質及健保財務永續。

- (三) 為使給付協議制度更具可預測性、公開性與公平性，健保署持續與業界溝通協作，致力建立互惠的運作模式。

二、Topic 2 : Sustaining Taiwan's World-Leading National Health Insurance System 永續經營台灣領先全球的全民健康保險制度

Key Questions 1 :

As MOHW continues planning for long term sustainability, what guiding principles does the MOHW see as most critical for maintaining both performance and financial resilience? 在衛福部持續規劃長遠永續發展之際，貴部認為維持健保效能與財務韌性最關鍵的指導原則為何？

【健保署】

持續推動藥品政策改革，爭取擴大新醫療科技預算，未來三年持續與各界溝通並研議藥價調整方案，確保健保財務穩定下的供藥韌性。

(一) 持續擴大新醫療科技預算

1. 健保署持續爭取新藥預算，參採廠商於「前瞻式新藥及新給付範圍預算推估登錄作業平台」提報預期收載之新藥及擴增給付規定資料，於預算編列年度申報增加之藥費，並確保新藥支出在健保總額可接受的範圍內穩定增長。
2. 同時，亦設立如罕藥及血友病專款、愛滋病、C 肝口服

新藥及暫時性支付專款等，透過「專款專用」保障重大醫療支出或特殊醫療者需求，並提高健保財政之彈性與穩定性。

3. 113 年健保總額藥品新醫療科技、給付規定改變及暫時性支付專款預算編列共計 60.49 億元，約為 112 年的兩倍；而自 114 年起，除健保總額內預算外，亦已公務預算挹注 50 億元設立之「癌症新藥暫時性支付專款」，新藥相關預算約 101.27 億元，突破百億規模，115 年亦較 114 年微幅成長達約 104.38 億元。
4. 近 5 年藥費平均成長率 3.91%，略高於健保總額平均成長率 3.85%。

(二) 推動健保藥政改革，強化供藥韌性作為

1. 推動健保藥政改革，提升藥品供應韌性：「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」部分條文及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」條文已於 114 年 4 月 26 日公告修正，包含：支持新藥在地製造、藥價合理保障、實施鼓勵使用生物相似藥及學名藥試辦計畫及適時調整健保支付價格。
2. 完備藥品韌性預算，保障合理藥價制度：114 年行政院已於「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」挹注全民健康保險基金 200 億元，以確保廠商藥品供應鏈不間斷，藥品廠商如有不敷成本，可依藥物給付項目及支付標準第 34、35 條規定，檢具成本分析向健保申請藥價調升，確保國人用藥供應無虞。
3. 藥物韌性整備計畫，確保供藥韌性：行政院已核定本部「國家藥物韌性整備計畫」4 年 240 億元以提升藥品韌性，其中挹注健保部分約 14.8 億元(四年期，115 年 2.36 億元)，將偕同食品藥物管理署盤點藥品項目，以確保藥品供應韌性。
4. DET 試辦計畫與各界溝通：健保署已規劃於 115 年下

半年，針對 DET 調價機制進行檢討，屆時亦將邀集各界進行討論以凝聚共識，因藥價差之議題與 DET 試辦計畫高度相關，將一併納入研議討論；衛福部亦責成國家衛生研究院與健保署將 DET 議題納入 115 年度國衛院論壇討論，將邀集產官學研界共同參與，同時參考國際經驗，討論藥價管理的可行方向。

Key Questions 2 :

Given recent conflict in Middle East potentially affecting medicine supply stability, we would appreciate the MOHW's views on Taiwan's approach to strengthening healthcare resilience and future preparedness. 在鑑於近期中東局勢動盪可能影響藥品供應的穩定性，我們誠摯希望能瞭解衛福部對於強化台灣醫療韌性及未來整備工作的看法與對策。

【健保署】

推動健保藥品政策改革，提升健保藥品供應韌性

(一) 持續推動健保藥品政策改革：

為確保我國健保用藥供應穩定，保障國民健康與生命安全，衛福部健保署於 114 年 4 月 26 日公告修正「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」與「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」，本次修正重點包含支持新藥在地製造、鼓勵生物相似藥及學名藥及早進入市場、國產藥品予以優惠調價、藥價合理保障等。

(二) 建立不敷成本調高藥價機制：

依藥物給付項目及支付標準第 34、35 條規定，廠商如不敷成本，可檢具相關資料向健保建議調高藥價，讓廠商反應成本以確保國人用藥供應無虞。113 年至 114 年依法調升藥品價格總

共約 350 項。

(三) 配合「國家藥物韌性整備計畫」，支持國產學名藥：

1. 依行政院核定之「國家藥物韌性整備計畫」，健保署配合「關鍵藥品清單」、就缺藥高風險藥品、國產藥品及血液製劑等，提供藥價保障及鼓勵醫療院所使用，以確保健保藥品供應韌性及民眾用藥可近性。
2. 韌性整備計畫 4 年共計 240 億元，其中挹注衛生福利部 60.15 億元推動「國藥國造」與「國藥國用」。國藥國用部分(挹注健保 14 億元)，健保署透過鼓勵使用關鍵藥品清單內成分之國產製劑、鼓勵醫療院所開立學名藥及生物相似藥處方，希望可以提升醫療院所使用國產藥品及學名藥及生物相似藥的比例。

【食藥署】

食藥署於 115 年 3 月 4 日完成修正藥事法，強化必要藥品許可證持有藥商，應定期申報藥品供應情形之義務；賦予中央衛生主管機關於具有許可證之藥品有供應不足之虞時，得專案核准製造或輸入，並於必要時適度調控藥品供應之法源依據；同時，將專案核准藥品納入適用藥害救濟制度。本次修法對於保障民眾用藥權益及維持藥品供應穩定，至為重要，未來食藥署將持續精進強化藥品供應韌性之法規環境。

三、Topic 3 : Collaboration on Digital Health, FHIR, RWD, and Precision Medicine (Focused on Immunology + Neurology) 數位醫療、FHIR、真實世界數據(RWD)及精準醫療之合作(聚焦於免疫學與神經科學領域) 全球的全民健康保險制度

Key Questions 1 :

What are the current key applications of FHIR/RWD in Taiwan, and what future development roadmap does MOHW envision? 目前 FHIR 與 RWD 在台灣的關鍵應用為何？此外，衛福部對未來的發展藍圖有何願景？？

【健保署】

(一) 健保署目前已導入院所以 FHIR 傳送健保資料之範圍及主要應用：

1. 範圍：

- (1) NGS:NGS 實作指引(下稱 IG)正式版於 114 年 8 月 12 日發布，目前已有 15 家醫院報名參與實作。
- (2) 癌症重大傷病：已完成 IG 測試，截至 115 年 3 月 23 日，已有 42 家醫院參與試辦，其中 39 家醫院已上傳 FHIR 測試案件，近期將正式開放醫院上傳使用。
- (3) 事前審查：截至 115 年 4 月已有 32 家醫院以 FHIR 申請癌藥事前審查；另統計近 3 個月資料，以 FHIR 格式申請共 7,089 件，占該等醫院癌藥總申請案件 33%，上半年朝向所有醫學中心都以 FHIR 申請為目標。

2. 應用：

- (1) 事前審查可透過結合醫院自主審查機制與自動化檢核規則，未來可大幅縮短藥物審查時間，提升治療效率與可近性。
- (2) 建置以病人為中心的癌症全程治療健保大數據資料庫，整合標準化與結構化的治療資訊，為臨床決策奠定實證基礎。

【資訊處】

(一) FHIR 在台灣的應用與國際銜接

目前 FHIR 在台灣的應用，核心在於我們已建立「**台灣核心資料群**」(TW Core IG)。

無縫接軌：TW Core IG 的設計完全對齊美國的核心資料群 (USCDI)，這確保國際藥廠的產品可以無縫接軌地轉移至台灣使用。

標準化格式：因為我們內部的資料、標準與格式皆與國際 FHIR 一致，僅經過必要的在地化擴充，極大化降低了國際藥廠進入台灣市場的技術門檻。

(二) 台灣健康三大空間(Taiwan Health Spaces)

在 TW Core IG 的基礎上，我們進一步建構了三大核心空間，這將是 UCB 未來可以充分利用的台灣數位生態系：

台灣健康資料空間(Taiwan Health Data Space)：未來將收納來自電子病歷(EMR)的**真實世界資料 (RWD)**，提供高品質、標準化 OMOP 格式的數據支持。

台灣健康規則空間(Taiwan Health Regulation Space)：用於政府與藥物申報的自動化。所有的程式規則都會存放在此空間，直接對接已經標準化的電子病歷，大幅提升申報效率。

台灣健康應用空間(Taiwan Health App Space)：這是一個國家的**醫療市集(National Marketplace)**。只要藥廠研發的應用程式符合 TW Core IG 與國際 SMART on FHIR 標準，就能透過這個市集進入全台灣的醫院。醫院可透過「訂閱經濟」的方式來取得並執行相關應用，對藥廠而言是極佳的推廣平台。

(三) 電子病歷標準化進程 (Roadmap)

我們政府提供的不只是資料標準，更包含整體的轉換工具，將其視為一套新的「醫療資料作業系統」。

- **2025 年**：已完成三大醫學中心的先導試驗，確認三家醫院資料可完全互通。

- **2026 年底**：全台 **30 家醫學中心**將達成全面互通。這意味著醫學中心在今年就具備全面化能力，可以對接國際以 FHIR 為基礎的應用程式或平台。
- **2027 年起**：將大規模推動至區域醫院及地區醫院。

(四) 國際合作成功案例

我們已經證實台灣的核心資料群可以與國際平台完美對接。目前的實績包括：

- 與 **Abbott(亞培)智慧實驗室**、歐洲 **bioMerieux** 抗生素管理及美國 **Varian (瓦里安)** 的放射腫瘤平台完成無縫對接。
- 這些國際平台皆符合 **TW Core IG** 與 **SMART** 標準，證明台灣的環境已準備好與國際藥廠(如 **UCB**)展開合作。
- 此外，這套「台灣經驗」已開始輸出國際，目前正與**捷克及泰國**展開相關合作。

(五) RWD 真實世界數據的應用空間

針對 RWD 的部分，目前健保資料申請。

- **合作模式**：藥廠可結合台灣研究者共同提出申請。
- **技術支持**：若需要將資料轉換為 **OMOP** 等國際標準格式進行分析，**衛福部資訊處**可提供技術支持，協助內容轉換。
- **實現目標**：在這樣的架構下，我們可以共同執行**藥物流行病學、真實世界效用(RWE)或人群副作用監測**等研究計畫。

參考資料：

<https://blog.mohw.gov.tw/1905/>

<https://blog.mohw.gov.tw/1426/>

<https://blog.mohw.gov.tw/1729/>

<https://blog.mohw.gov.tw/459/>

<https://blog.mohw.gov.tw/989/>

Key Questions 2 :

If possible, could MOHW share how to leverage NHIA data for RWE and any great examples for us to learn? 若方便的話，建請衛福部分享如何運用健保署（NHIA）數據來產出真實世界證據（RWE），以及是否有值得我們學習的卓越案例？

【健保署】

2019 年健保採行「先給付、再評估」模式，率先各國給付部分癌症免疫治療藥品，一次核准三項免疫檢查點抑制劑，涵蓋八個癌別，並同步蒐集真實世界資料，以評估其實際療效與成本效益。實際給付一年後資料分析顯示，部分癌別治療效益有限，病人實際用藥反應達完全或部分反應之比例偏低，在肝癌與胃癌之整體療效僅與既有傳統治療相當，爰後續取消該適應症之健保給付；其後，美、英主管機關亦作出相同調整，顯示此一動態評估機制具前瞻性與國際趨勢一致。

考量新醫療科技的快速發展，針對已取得食品藥物管理署核發藥品許可證，且屬醫療迫切需求（unmet medical need），但臨床價值及成本效益具高度不確定性之新藥，自 2023 年起，可透過「暫時性支付」制度先行納入健保給付。在暫時性支付的 2~3 年期間，將系統性蒐集臨床試驗或真實世界數據，辦理醫療科技再評估，作為後續審議，與決定是否納入常規健保給付，確保健保制度兼顧創新、實證與永續發展。

**We are UCB.
Inspired by patients.
Driven by science.**



Inspired by patients.
Driven by science.



UCB Attendants

UCB is represented by our international and local leadership team, reflecting the strategic importance we place on collaboration with the MOHW

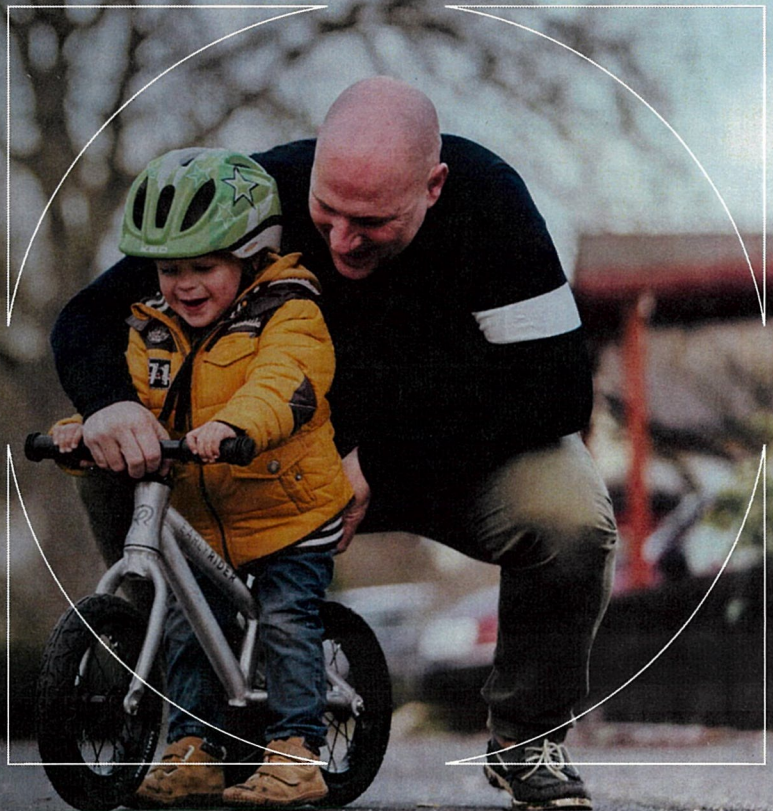
- **Ms. Athanasia Gkiouleka — UCB 國際市場總裁**
- **李宜真 — UCB 東國際市場副總裁**
- **郭佳薇 — UCB 台灣香港總經理**
- **孫崇原 — UCB 台灣罕病暨癲癇藥物處長**
- **羅柏青 — UCB 台灣市場准入、永續發展暨對外事務處長**
- **許書諭 — UCB 台灣法規處長**
- **郭睿臻 — UCB 台灣神經醫學事業處主管**
- **劉旅帆 — UCB 東國際市場副總裁行政特助**



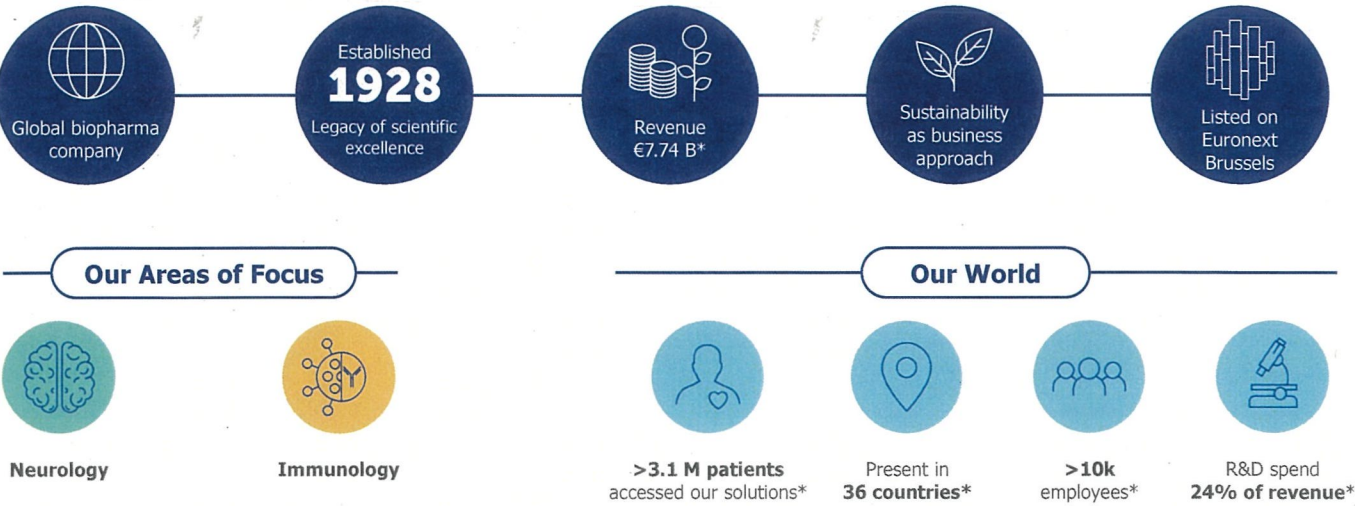
UCB Introduction



We are UCB.
Inspired by patients.
Driven by science.



Our company in a nutshell



Inspired by patients. Driven by science.

*As of December 2025. Source: UCB Integrated Annual Report 2025. Available at [Integrated Annual Report 2025 | UCB](#). Accessed February 2026.
GL-DA-2200028 Date of preparation: February 2026 © UCB Biopharma SRL, 2026. All rights reserved.

We are defined by our purpose:

Creating value for patients now and into the future.

We strive to make a positive impact on society.



We believe that **everyone deserves to live the best life that they can** - as free as possible from the challenges and uncertainty of disease.



We continuously innovate, inspired by the needs of people living with severe diseases

Connecting science in new ways – **chemistry** (small molecules), **biology** (large molecules) and **gene therapy** to leverage the potential of these disciplines.



4 research satellites

Durham and Seattle (U.S.)
Leuven (Belgium)
King's College London (U.K.)



3 strategic research centers

Braine-l'Alleud (Belgium)
Slough (U.K.)
Boston area (U.S.)



7 development sites

Braine-l'Alleud and Leuven (Belgium)
Monheim (Germany)
Raleigh (U.S.)
Slough (U.K.)
Tokyo (Japan)
Shanghai (China)



3 manufacturing sites

Braine-l'Alleud (Belgium)
Saitama (Japan)
Bulle (Switzerland)



GL-DA-2200028 Date of preparation: February 2026 © UCB Biopharma SRL, 2026. All rights reserved.

We focus on uncovering the molecular and biological complexities of diseases

By combining the power of combinatorial biology with advanced rational drug design, utilizing artificial intelligence, we can identify highly promising therapeutic candidates with precision and efficiency.



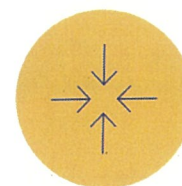
Populations

We leverage genetic, biological and chemical insights to understand the underlying causes of health conditions and identify patient populations that may benefit from targeted therapies.



Pathways

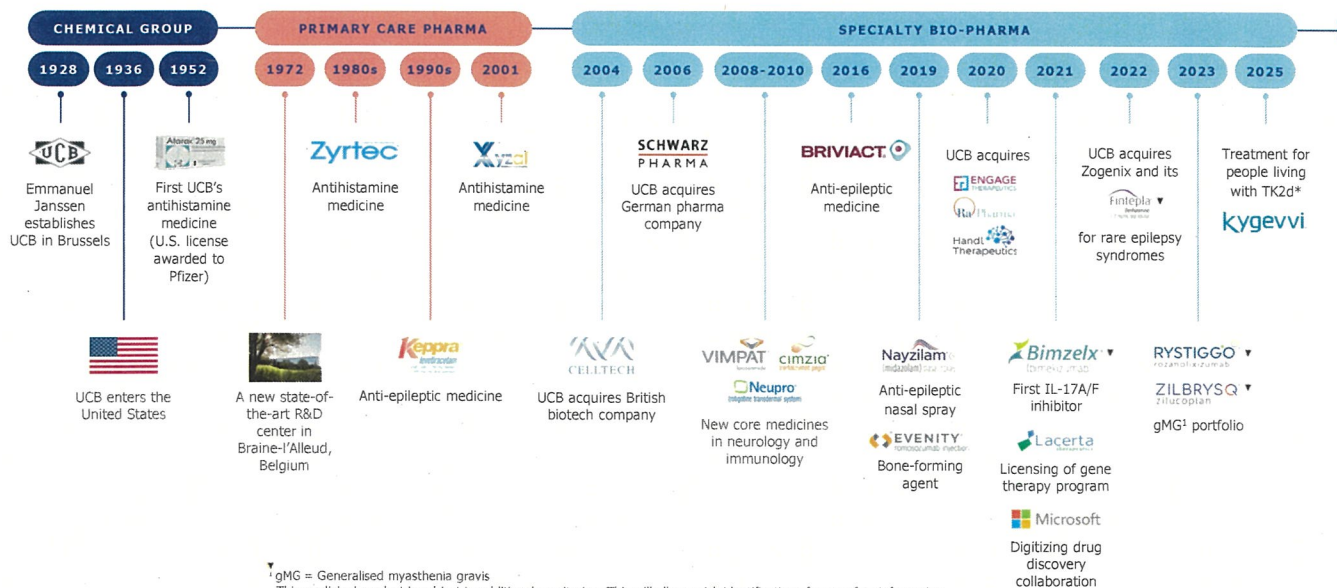
We identify the key biological pathways involved in disease processes and develop strategies to modulate these pathways.



Platforms

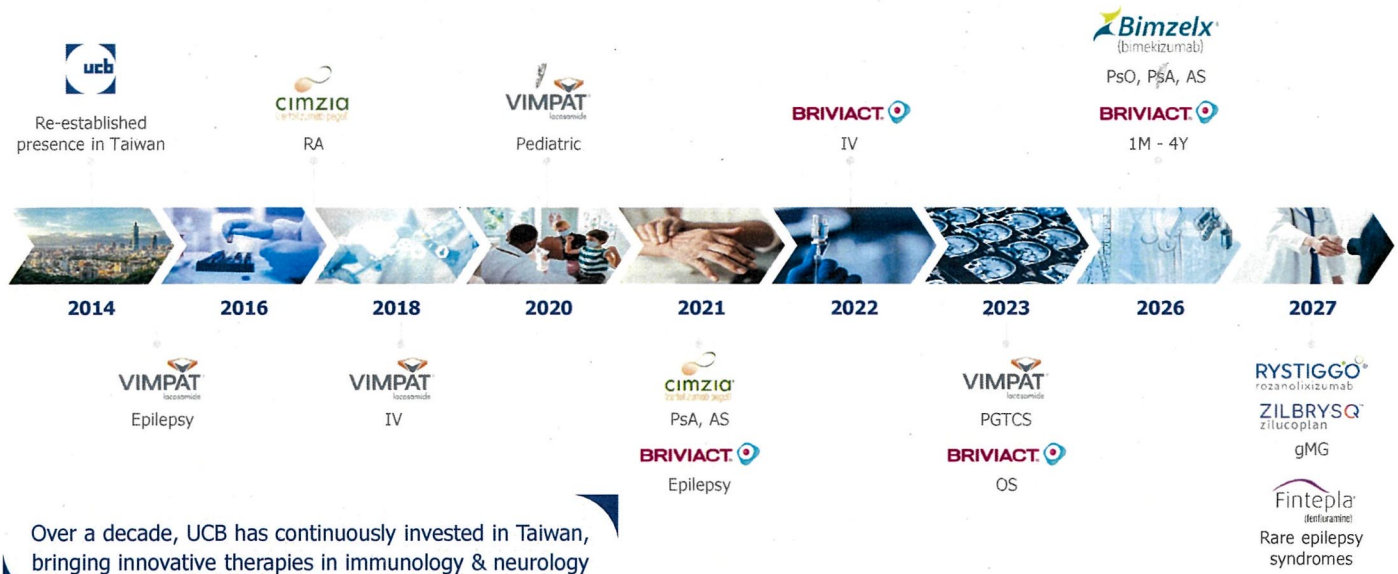
We use our innovative technology platforms to discover and develop new therapies that can effectively target these pathways.

Rooted in a heritage of delivering valuable, innovative solutions



UCB Taiwan

A Committed Partner Advancing Patient-Centric Innovation



Inspired by patients.
Driven by science.

* Zilbrysq and Fintepla is under registration.

Proprietary and Confidential Property of UCB

11

UCB Taiwan

Accelerating Access to Innovative Therapies for Patients Living with Severe Disease



Inspired by patients.
Driven by science.

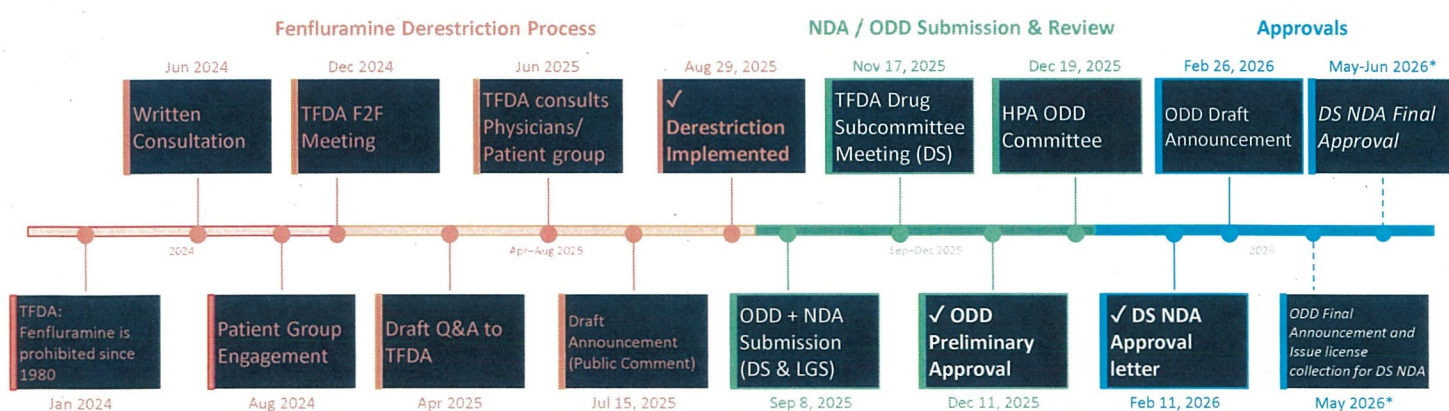
Proprietary and Confidential Property of UCB

12

 Inspired by patients.
Driven by science.

13

UCB appreciates the FDA's efforts and recent streamlined orphan drug process to drive earlier patient access.



DS: Dravet Syndrome; LGS: Lennox-Gastaut syndrome; NDA: New Drug Application; ODD: Orphan Drug Designation

* Tentative dates

Taiwan's Healthcare Policy Progress: UCB's Understanding and Recognition

UCB appreciates the Ministry of Health and Welfare (MOHW) and TFDA for the significant policy reforms in recent years, demonstrating strong commitment to **medical innovation, patient access, and long-term healthcare sustainability**.

Accelerated New Drug Review and Expanded Patient Access

- MOHW has introduced multiple initiatives to **accelerate new drug availability**, including parallel review, temporary reimbursement mechanisms, and rolling updates to reimbursement guidance.
- The government has also significantly increased the **new drug budget from NT\$6B (2024) to NT\$10.1B (2025)**, highlighting its commitment to expand patient access to innovation.

Establishment of an HTA Center for a More Scientific and Predictable Reimbursement Process

- Advancement toward establishing an **independent Health Technology Assessment (HTA) Center**, strengthening evaluation frameworks grounded in real-world evidence (RWE) and international standards, thereby enhancing both efficiency and transparency in decision-making.

Rapid Development of Digital Health, FHIR, and the RWD Ecosystem

- Taiwan is actively promoting next-generation data standards such as **FHIR**, particularly for NGS and precision-medicine applications.
- Progress in developing a more robust **real-world data (RWD)** infrastructure creates new opportunities for evidence generation to support future clinical and reimbursement decision-making.

Key Topics for Joint Discussions

Topic 1 : Accelerating Access to Innovative Therapies in Taiwan and the NHI System

The government aims to accelerate new drug review and expand patient access where UCB is strongly committed.

Key Questions

- How would you describe the recent progress in Taiwan's **new drug regulatory** and **reimbursement review timelines**, and what future directions MOHW envisions for accelerating access?
- Building on existing parallel review and temporary reimbursement mechanisms, would the government consider a clearer **accelerated pathway** for rare diseases?
- Would the government consider exploring more **value-based healthcare models**, such as outcome-based MEAs, to improve access to innovation while maintaining budget stability?

Topic 2: Sustaining Taiwan's World-Leading National Health Insurance System

Taiwan's National Health Insurance (NHI) is globally recognized for its accessibility, efficiency, and equity. As the NHI marks its 30th anniversary, UCB would appreciate the opportunity to learn from MOHW's experience in balancing high performance and long-term sustainability

Key Questions

- As MOHW continues planning for long-term sustainability, what **guiding principles** does the Ministry see as most critical for maintaining both performance and financial resilience?
- Given recent conflict in Middle East potentially affecting medicine supply stability, we would appreciate the MOHW's views on Taiwan's **approach to strengthening healthcare resilience** and future preparedness

Topic 3: Collaboration on Digital Health, FHIR, RWD, and Precision Medicine (Focused on Immunology + Neurology)

Taiwan is building a rapidly evolving FHIR + NGS + RWD ecosystem that aligns well with UCB's research priorities.

Key Questions

- What are the **current key applications of FHIR/RWD** in Taiwan, and what **future development roadmap** does MOHW envision?
- If possible, could MOHW share how to leverage NHIA data for RWE and any great examples for us to learn?

UCB fully respects Taiwan's data governance framework and aims to support evidence generation in a compliant and collaborative manner



Inspired by **patients.**
Driven by **science.**

115.5.22 優時比公司(UCB)拜會_談參資料

■ Topic 1 : Accelerating Access to Innovative Therapies in Taiwan and the NHI System 加速創新療法引進台灣：新產品與新適應症的審查合作

Key Questions 1 :

How would you describe the recent progress in Taiwan's **new drug regulatory and reimbursement review timelines**, and what future directions MOHW envisions for accelerating access? 如何評價近期台灣新藥法規及健保給付審查時程的進展情況？未來衛福部在加速患者取得新藥方面，有何方向規劃？

說明：

一、為加速健保新藥納入給付，健保近年推動多項創新藥品審查策略：

(一) 法規面

於 2025 年 4 月 26 日公告修正「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」部分條文，兼顧藥品供應穩定性、用藥可及性與產業升級，包含建立誘因支持新藥在地製造、藥價合理保障及適時調整健保支付價格等，並鼓勵學名藥與生物相似藥及早進入市場。各項優惠已於政策面實質運用。

(二) 制度面

1. 2023 年實施暫時性支付制度；2024 年推動平行送審機制，將新藥核價審查時間縮短至最快可於取得藥證後 6 個月納入健保給付。
2. 2024 年成立健康政策與醫療科技評估中心(CHPTA)專責辦公室，強化醫療科技評估，以實證為基礎之支付，並將設置行政法人國家醫療科技評估中心。

(三) 預算面

1. 2025 年健保藥品相關預算共約 101.27 億元，2026 年達 104.38 億元(包含總額內新醫療科技 25.59 億元、藥品給付規定範圍改變 24.29 億元及非癌藥之暫時性支付專款 4.5 億元；加上總額外公務預算挹注 50 億元至癌症新藥暫時性支付專款)，大幅增加新藥收載項目。
2. 擴大新藥預算來源，2025 年設立「癌症新藥暫時性支付專款」，2025 及 2026 年各編列 50 億元。2025 年透過癌症新藥暫時性支

付專款，增加收載 10 項癌症新藥/擴增給付規定(涵蓋 8 種癌別)，加速接軌國際治療指引，提升病人新藥之可近性。

二、健保給付審查時程的進展情況：

(一) 自 2024 年起，透過 CHPTA 專責辦公室的輔助，2024 年及 2025 年廠商送件到提第一次專家會議的平均天數為 3.7~3.9 個月，相較 112 年 4.3 個月，有顯著提升。

(二) 自 2024 年平行送審機制推行後，截至 2026 年 5 月，共 8 項新藥採平行送審公告生效給付，自取得藥證至生效之中位數約 9.5 個月 (最短為約 3.5 個月)。

(三) 癌症新藥暫時性支付：2025 年透過癌症新藥暫時性支付專款共收載 10 項藥品，其中 8 項為食藥署查驗登記加速核准案件，且其中 6 項藥品三大 HTA 組織並未皆建議，健保給付先於十國。

三、健保署將持續精進新藥納入健保收載流程，並期透過成立行政法人國家醫療科技評估中心，強化我國醫療科技評估人才及量能，提升國人用藥可近性。

Key Questions 2：

Building on existing parallel review and temporary reimbursement mechanisms, would the government consider an **accelerated pathway** for rare diseases? 在現有的「平行審查」與「暫時性支付」機制基礎上，政府是否會考慮針對罕見疾病設立加速審查通道？

說明：

罕藥於 103 年起，經公告為「適用罕見疾病及藥物防治法之藥物」，且取得衛生福利部食品藥物管理署核准之專案進口或專案製造函，廠商未取得藥品許可證，即可向健保署建議收載，且在尚未取得藥品許可證之情形下亦可提至藥物共同擬訂會議討論收載。爰現行健保罕藥的審查已優於平行送審機制，且已列為優先審查案件，以提升病人用藥可近性。

Key Questions 3 :

Would the government consider exploring more **value-based healthcare models**, such as outcome-based MEAs, to improve access to innovation while maintaining budget stability? 政府是否願意探索更多「價值導向醫療模式」，例如以療效結果為基礎的 MEA 模式，以在維持預算穩定的同時改善創新藥物的可及性？

說明：

- 一、為因應新藥引進過程中因臨床證據、成本效益或財務風險等不確定性所帶來的挑戰，健保署透過藥品給付協議與風險分擔機制等，提供廠商多元方式納入健保，在健保總額制度下，使新藥納入健保收載可更靈活、彈性的運用，以達促進創新藥給付與上市速度之目標，讓病人可儘快使用到藥物及降低其經濟負擔。
- 二、目前健保除以財務為基礎的給付協議外，亦有簽訂以療效為基礎的協議(如 Zolgensma)。針對以療效為基礎的給付協議，健保持開放態度，尤其是罕病或是基因療法等新治療藥物，將依據藥物的特性、療效證據及病人需求，與廠商共同協商，靈活調整最適宜的給付模式，以兼顧病人醫療品質及健保財務永續。
- 三、為使給付協議制度更具可預測性、公開性與公平性，健保署持續與業界溝通協作，致力建立互惠的運作模式。

■ Topic 2 : Sustaining Taiwan's World-Leading National Health Insurance System 永續經營台灣領先全球的全民健康保險制度

Key Questions 1 :

As MOHW continues planning for long-term sustainability, what guiding principles does the MOHW see as most critical for maintaining both performance and financial resilience? 在衛福部持續規劃長遠永續發展之際，貴部認為維持健保效能與財務韌性最關鍵的指導原則為何？

說明：持續推動藥品政策改革，爭取擴大新醫療科技預算，未來三年持續與各界溝通並研議藥價調整方案，確保健保財務穩定下的供藥韌性。

一、 持續擴大新醫療科技預算

- (一) 健保署持續爭取新藥預算，參採廠商於「前瞻式新藥及新給付範圍預算推估登錄作業平台」提報預期收載之新藥及擴增給付規定資料，於預算編列年度申報增加之藥費，並確保新藥支出在健保總額可接受的範圍內穩定增長。
- (二) 同時，亦設立如罕藥及血友病專款、愛滋病、C 肝口服新藥及暫時性支付專款等，透過「專款專用」保障重大醫療支出或特殊醫療者需求，並提高健保財政之彈性與穩定性。
- (三) 113 年健保總額藥品新醫療科技、給付規定改變及暫時性支付專款預算編列共計 60.49 億元，約為 112 年的兩倍；而自 114 年起，除健保總額內預算外，亦已公務預算挹注 50 億元設立之「癌症新藥暫時性支付專款」，新藥相關預算約 101.27 億元，突破百億規模，115 年亦較 114 年微幅成長達約 104.38 億元。
- (四) 近 5 年藥費平均成長率 3.91%，略高於健保總額平均成長率 3.85%。

二、 推動健保藥政改革，強化供藥韌性作為

- (一) 推動健保藥政改革，提升藥品供應韌性：「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」部分條文修正及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」條文修正已於 114 年 4 月 26 日公告，包含：支持新藥在地製造、藥價合理保障、實施鼓勵使用生物相似藥及學名藥試辦計畫及適時調整健保支付價格。

- (二) 完備藥品韌性預算，保障合理藥價制度：14 年行政院已於「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」挹注全民健康保險基金 200 億元，以確保廠商藥品供應鏈不間斷，藥品廠商如有不敷成本，可依藥物給付項目及支付標準第 34、35 條規定，檢具成本分析向健保申請藥價調升，確保國人用藥供應無虞。
- (三) 藥物韌性整備計畫，確保供藥韌性：行政院已核定本部「國家藥物韌性整備計畫」4 年新臺幣 240 億元以提升藥品韌性，其中挹注健保部分約 14.8 億元(四年期，115 年 2.36 億元)，將偕同食品藥物管理署盤點藥品項目，以確保藥品供應韌性。
- (四) DET 試辦計畫與各界溝通：本署已規劃於 115 年下半年，針對 DET 調價機制進行檢討，屆時亦將邀集各界進行討論以凝聚共識，因藥價差之議題與 DET 試辦計畫高度相關，將一併納入研議討論；衛福部亦責成國家衛生研究院與本署將 DET 議題納入 115 年度國衛院論壇討論，將邀集產官學研界共同參與，同時參考國際經驗，討論藥價管理的可行方向。

Key Questions 2 :

Given recent conflict in Middle East potentially affecting medicine supply stability, we would appreciate the MOHW's views on Taiwan's approach to strengthening healthcare resilience and future preparedness. 在鑑於近期中東局勢動盪可能影響藥品供應的穩定性，我們誠摯希望能瞭解衛福部對於強化台灣醫療韌性及未來整備工作的看法與對策。

說明：推動健保藥品政策改革，提升健保藥品供應韌性

一、 持續推動健保藥品政策改革：

為確保我國健保用藥供應穩定，保障國民健康與生命安全，衛福部健保署於 114 年 4 月 26 日公告修正「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」與「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」，本次修法重點包含支持新藥在地製造、鼓勵生物相似藥及學名藥及早進入市場、國產藥品予以優惠調價、藥價合理保障等。

二、 建立不敷成本調高藥價機制：

依藥物給付項目及支付標準第 34、35 條規定，廠商如不敷成本，可檢具相關資料向健保建議調高藥價，讓廠商反應成本以確保國人用藥供應無虞。113 年至 114 年依法調升藥品價格總共約 350 項。

三、 配合「國家藥物韌性整備計畫」，支持國產學名藥：

- (一) 依行政院核定之「國家藥物韌性整備計畫」，健保署配合「關鍵藥品清單」、就缺藥高風險藥品、國產藥品及血液製劑等，提供藥價保障及鼓勵醫療院所使用，以確保健保藥品供應韌性及民眾用藥可近性。
- (二) 韌性整備計畫 4 年共計 240 億元，其中挹注衛生福利部 60.15 億元推動「國藥國造」與「國藥國用」。國藥國用部分(挹注健保 14 億元)，健保署透過鼓勵使用關鍵藥品清單內成分之國產製劑、鼓勵醫療院所開立學名藥及生物相似藥處方，希望可以提升醫療院所使用國產藥品及學名藥及生物相似藥的比例。

■ Topic 3 : Collaboration on Digital Health, FHIR, RWD, and Precision Medicine (Focused on Immunology + Neurology) 數位醫療、FHIR、真實世界數據 (RWD) 及精準醫療之合作 (聚焦於免疫學與神經科學領域) 全球的全民健康保險制度

Key Questions 1 :

What are the current key applications of FHIR/RWD in Taiwan, and what future development roadmap does MOHW envision? 目前 FHIR 與 RWD 在台灣的關鍵應用為何？此外，衛福部對未來的發展藍圖有何願景？？

說明：

一、健保署目前已導入院所以 FHIR 傳送健保資料之範圍及主要應用：

(一) 範圍：

1. NGS：NGS 實作指引(下稱 IG)正式版於 114 年 8 月 12 日發布，目前已有 15 家醫院報名參與實作。
2. 癌症重大傷病：已完成 IG 測試，截至 115 年 3 月 23 日，已有 42 家醫院參與試辦，其中 39 家醫院已上傳 FHIR 測試案件，近期將正式開放醫院上傳使用。
3. 事前審查：截至 115 年 4 月已有 32 家醫院以 FHIR 申請癌藥事前審查；另統計近 3 個月資料，以 FHIR 格式申請共 7,089 件，占該等醫院癌藥總申請案件 33%，上半年朝向所有醫學中心都以 FHIR 申請為目標。

(二) 應用：

1. 事前審查可透過結合醫院自主審查機制與自動化檢核規則，未來可大幅縮短藥物審查時間，提升治療效率與可近性。
2. 建置以病人為中心的癌症全程治療健保大數據資料庫，整合標準化與結構化的治療資訊，為臨床決策奠定實證基礎。

二、(衛福部對未來發展藍圖規劃，建議由衛福部業管單位回復)

Key Questions 2 :

If possible, could MOHW share how to leverage NHIA data for RWE and any great examples for us to learn? 若方便的話，建請衛福部分享如何運用健保署（NHIA）數據來產出真實世界證據（RWE），以及是否有值得我們學習的卓越案例？

說明：

2019 年健保採行「先給付、再評估」模式，率先各國給付部分癌症免疫治療藥品，一次核准三項免疫檢查點抑制劑，涵蓋八個癌別，並同步蒐集真實世界資料，以評估其實際療效與成本效益。實際給付一年後資料分析顯示，部分癌別治療效益有限，病人實際用藥反應達完全或部分反應之比例偏低，在肝癌與胃癌之整體療效僅與既有傳統治療相當，爰後續取消該適應症之健保給付；其後，美、英主管機關亦作出相同調整，顯示此一動態評估機制具前瞻性與國際趨勢一致。

考量新醫療科技的快速發展，針對已取得食品藥物管理署核發藥品許可證，且屬醫療迫切需求（unmet medical need），但臨床價值及成本效益具高度不確定性之新藥，自 2023 年起，可透過「暫時性支付」制度先行納入健保給付。在暫時性支付的 2~3 年期間，將系統性蒐集臨床試驗或真實世界數據，辦理醫療科技再評估，作為後續審議，與決定是否納入常規健保給付，確保健保制度兼顧創新、實證與永續發展。

一、台灣優時比貿易有限公司健保收載藥品情形

UCB公司
藥品申報情形

健保已收載品項 (截至 115.3)	13 項 (以一般錠劑膠囊劑、注射液為大宗)
年申報藥費	112 年：10.79 億元
	113 年：12.38 億元
	114 年：13.45 億元

(一) 品項分析 (截至 115 年 3 月)

調整大類	第一大類	4 項
	第二大類	1 項
	三 A 大類	8 項
	三 B 大類 (三同)	0 項
	特殊藥品/不可替代特殊藥品	0 項
	罕藥	0 項

(二) 申報金額最高前五名藥品

中文品名	英文品名	規格	適應症	115.3 健保支付價(元)	114 年 醫令申報金額(元)
欣膝亞注射液	Cimzia solution for injection	200 毫克/毫升	類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎及乾癬等	9,675	6 億 5,696 萬
維帕特	Vimpat	10 毫克/毫升輸液溶液	局部癲癇發作病人的單一藥物治療或原發性全面強直陣攣發作	992	4 億 9,525 萬
		膜衣錠： 50/100/150/200mg		26.3/48.7/75/88	
必治癲	Briviact	膜衣錠 50/100mg	1 個月大以上局部癲癇發作病人的治療	46.4	1 億 2,572 萬
		注射液 10 毫克/毫升		801	
		口服溶液 10 毫克/毫升		2,618	
紐普洛穿皮貼片劑	Neupro Transdermal Patch	4 毫克/ 24 小時	原發性帕金森氏症	59	6,779 萬
		6 毫克/ 24 小時		85	
		8 毫克/ 24 小時		91	

分文年	新藥系統案件編號	案件類別	提議單位	藥品名稱	建議者 非國同仁	建議事項(適應症)	CDE收案日期 (行政審)	CDE評估結果	已進會議	本料同仁辦理情形	進度 (下拉式選單)	115年1月 提會(有補 件V, 無則 空白)
114 (CDE)	4202507220001981	2. 給付規定 (非癌)	台灣優時比 貿易有限公司	Briviact	林昱伶	適用於1個月大以上局部癲癇發作 病人的治療。及局部癲癇發作之第 一線單獨或輔助治療	114/7/30		114年12月專家(非 癌藥)第7案	1140814 正式送件 114年12月專家 115年3月專家(報告案)	3. 已進專家	
115(CDE)	3202602100019753	1. 新藥 (非癌)	台灣優時比 貿易有限公司	Zilbrysq Solution for injection (zilucoplan)	羅培心	作為標準治療的附加治療，用於治 療抗乙酰膽鹼受體(AChR)抗體陽性 之全身型重症肌無力(gMG)成人病 人。	115/2/13				2. 評估中	
115(CDE)	3202602100019752	1. 新藥 (非癌)	台灣優時比 貿易有限公司	Rystiggo (rozanolixizumab)	羅培心	作為標準治療的附加治療，用於治 療抗乙酰膽鹼受體(AChR)抗體陽性 或抗肌特異性酪氨酸激酶(MuSK)抗 體陽性之全身型重症肌無力(gMG) 成人病人。	115/2/13			預計提115年7月專家	2. 評估中	
115(CDE)	3202603260020054	1. 新藥 (非癌-罕)	台灣優時比 貿易有限公司	飛癲寧2.2毫克1毫升口服 溶液 Fintepla(fenfluramine) Oral Solution 2.2mg/ml	陳玄然	適用於治療2歲以上Dravet症候群病 人之癲癇發作	115/4/1(請廠商補件) 115/4/7(廠商完成補件)				1. 待送件	